

05 - 02- L'hystérie - Pr. Adali

Merci d'avoir assisté au cours via Zoom. Donc aujourd'hui, notre cours portera sur l'hystérie. Et je vous le dis dès maintenant, dans le DSM 5, qui est le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, si vous cherchez le terme hystérie, vous n'allez pas le trouver.

Parce qu'en fait, il n'y a pas une pathologie particulière qui s'appelle hystérie, mais plutôt plusieurs sous-pathologies. Il faut savoir que le terme hystérie est une terminologie ou une nosographie française. C'est parmi les pathologies où l'ancienne nomenclature tient toujours.

Et j'ai trouvé, pour le plan de mon cours, que c'était la nomenclature la plus adéquate. Et on va voir en détail. Vous avez déjà entendu parler du terme hystérie? Oui ou non? Quand et où? Oui? Oui? On parle d'hystérie collective, c'est-à-dire dans quelle situation? Précisez plus.

Mouvement de foule? D'accord. Les autres? Oui? Comme motif de consultation? C'est une crise d'hystérie. Déjà, vous introduisez le terme crise d'hystérie.

D'accord. Et cette crise d'hystérie, c'est-à-dire c'est une patiente qui vient consulter pour un symptôme organique et on se rend compte que c'est une crise d'hystérie. Comment on se rend compte que c'est une crise d'hystérie? Terrain antécédent? D'accord.

Éliminer l'organique? Oui. Les autres? Vous avez fait déjà des gardes dans les urgences? Oui ou non? Alors, vous n'avez jamais vu des patientes qu'on qualifie d'hystériques? Excusez-moi, je dois répondre parce que je suis de garde. En qualifiant d'hystérique, qui sont les personnes qu'on peut qualifier d'hystériques? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux? On dit, celle-là, elle est hystérique.

Elle est un peu hystérique. C'est un terme qu'on utilise aussi dans le langage quotidien, dans le jargon autre que médical. Donnez-moi les caractéristiques d'une personne hystérique, si vous savez, si vous avez déjà entendu parler de ça.

Oui, mademoiselle? Dramatise? Exagère? Oui. C'est-à-dire? Mais est-ce qu'on utilise le terme hypochondriac dans notre jargon quotidien? Hypochondrique, c'est un terme médical, d'accord? Je parle du langage hystérique. Donc, elle exagère, elle dramatise? Oui.

C'est-à-dire? Compulsive, c'est-à-dire? Impulsive, tu veux dire. Impulsive, oui. Elle réagit de manière exagérée? Oui.

Donnez-moi des exemples concrets. Comment elle peut faire? Donnez-moi une situation et, oui, face à quoi? Donnez-moi un exemple concret. Donnez-moi des exemples vagues, une situation.

Donnez-moi situation X, la personne va se comporter de la façon Y. Oui. Elle se met en? Elle va s'évanouir. Très bien.

Donc, par exemple, une situation de conflit, mari et femme, elle va s'évanouir. Justement, la crise hystérique, c'est ça ce que je voulais que vous me dites, que vous décrivez, c'est votre garde aux urgences. On vous ramène une personne inconsciente, entre parenthèses, avec perte de connaissances.

Qu'est-ce qu'on va vous dire? La famille va vous dire quoi? Quand vous prenez le pouls, les constantes, tout est normal. Donc, la personne, ce n'est pas une perte de connaissances. Ce n'est pas un arrêt cardio-respiratoire.

Oui ou non? La famille va vous rapporter. Donc, vous éliminez l'urgence vitale, c'est-à-dire qu'il n'est pas en coma, la personne n'a pas de défaillance respiratoire, ou la cardiaque, ou là, ou là, ou là. D'accord? Et là, vous dites, c'est une personne qui a des constantes normales et elle s'évanouit.

D'accord? Là, vous demandez à la famille, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Elle va vous rapporter quoi? Qu'il y a eu un conflit, par exemple, avec le mari. C'est un motif de consultation extrêmement fréquent en médecine générale, aux urgences, des hôpitaux généraux. Peut-être que vous faites les gardes, probablement, vous faites les gardes aux urgences CHU, mais quand vous allez être en stage interné en septième année, on va voir si c'est la sixième année ou la septième année, je ne sais pas si la loi s'applique à vous, je ne me rappelle pas.

Donc, quand vous allez faire la garde aux urgences, ou là, même les centres de santé, vous allez voir, vous allez être confronté à ce genre de situation très fréquemment. Donc, les médecins de famille ou les médecins généralistes verrent très souvent ce genre de situation. C'est plus fréquent que vous l'imaginez.

Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une pathologie qui est complexe, complexe par les symptômes, complexe par la définition. Il n'y a pas de consensus sur une définition de l'hystérie. Le terme hystérie est une définition ancienne, française, mais qui garde son importance, comme je l'ai dit.

C'est une pathologie qui est source de souffrance et d'invalidité. On va voir pourquoi. C'est considéré comme une maladie de l'imagination aux pratiques médicales quotidiennes.

Oui ou non ? Oui ou non ? Parce que dans la majorité des cas, c'est des patients qui viennent. Vous êtes de garde aux urgences. Vous avez passé 24 heures.

Vous avez eu des traumatismes crâniens. Vous avez vu des crises d'asthme sévère. Vous avez vu des plaies.

Peut-être même que vous êtes devant un séisme et qu'on vous a ramené beaucoup de victimes. Et la famille vous ramène une patiente qui, comparée aux patients que vous venez de voir, n'a pas de problème qui engage le pronostic vital. Alors que vous, vous n'avez pas cessé de voir les

traumas crâniens graves.

Des gens qui vont peut-être, doivent être opérés, qui vont peut-être mourir, qui auront des répercussions organiques graves à long terme. Et la famille, alors qu'ils ne vont manquer plus que ça, vous ramène une patiente constante, normale. Qu'est-ce que vous allez sentir ? Vous allez sentir, en fait, même si vous êtes médecin empathique et tout, mais qu'est-ce que vous allez sentir ? La colère, oui.

Une perte de temps, oui ou non ? Je suis en train de perdre mon temps avec une patiente qui n'a pas, en fait, de problème. Et si tu m'as dit de l'imagination, c'est juste dans sa tête. Peut-être même que vous allez croire, vous allez vous dire que c'est, elle le fait exprès, elle simule, oui ou non ? Donc, c'est comparé aux autres patients, aux vrais patients, en fait.

Vrai, quand je dis vrai, c'est entre parenthèses. Aux vrais patients, ce n'est pas une patiente, en fait. C'est juste une personne, une personne qui vient consommer votre temps, votre énergie, les traitements à l'hôpital, le temps à temps précieux qu'on peut utiliser pour sauver d'autres personnes, oui ou non ? C'est ça ce qui vient, en fait, dans votre tête.

Vous n'êtes pas obligé de le dire à la patiente, mais c'est ici. Le souci aussi avec ce qui rend cette pathologie complexe, c'est qu'il y a des diagnostics en excès de l'hystérie par les somaticiens. Vous vous rappelez qu'on dit somaticien par rapport au psychiatre, c'est les gens qui s'intéressent à toutes les pathologies organiques, c'est les médecins qui s'intéressent aux pathologies organiques, par rapport à de réelles pathologies organiques.

C'est la même patiente, moi je vous donne le même exemple, c'est la même patiente, vous travaillez dans les urgences, vous la foncez en santé, vous connaissez un petit peu la population, c'est la même patiente qui vient vous voir à chaque fois pour le même motif. Chaque fois que son mari ne lui donne pas de l'argent, chaque fois qu'elle a un conflit familial, chaque fois que son enfant tombe malade, ils vont la ramener à l'hôpital. Vous la connaissez un peu, imaginez que cette fois, même si c'est une chance sur un million, que cette patiente, par exemple, fasse une réelle crise épileptique et que la famille vous la ramène pour la même symptomatologie.

Elle est en perte de connaissance, vous allez faire quoi ? La même conduite à tenir qu'avant, on va voir quelle a été votre conduite à tenir. Est-ce que vous allez prendre la peine d'examiner la patiente, de demander déjà à la famille, est-ce qu'elle a fait une crise épileptique ? Elle vient en état de mal, c'est-à-dire en confusion post-critique, elle est confuse, elle a une perte de connaissance. Est-ce que vous allez l'examiner ? Non, oui ou non ? Soyons logiques, c'est une récidivisme, c'est une patiente qui vient vous voir à chaque fois, elle vous fait perdre votre temps.

Vous n'allez même pas prendre la peine de l'examiner, d'éliminer une pathologie organique. C'est ce qui fait que beaucoup de médecins diagnostiquent en excès les crises épileptiques, les crises conversives. Il y a beaucoup de patientes qui viennent pour des symptomatologies neurologiques, une impotence fonctionnelle, un trouble de la sensibilité, des douleurs

musculaires, des douleurs neurologiques.

Et quand le médecin a examiné un petit peu, il n'a pas poussé, il demande à la patiente. Et là, bien sûr, quand on demande des conflits, il a des problèmes relationnels, comme tout le monde, et étiquette, comme vous l'avez dit, c'est phallée, crise d'hystérie. On va voir, c'est confirmé par des chiffres, on va voir combien de patientes sont surdiagnostiquées en temps hystérique.

C'est une source de stigmatisation, on vient de l'expliquer, parce que ce sont des patientes qui ne sont pas considérées comme de vraies malades par rapport aux patients classiques que vous voyez. Oui ou non ? Pour vous, une personne réellement malade, c'est une personne qui doit avoir des symptômes objectifs. Oui ou non ? Mais donnez-moi un feed-back.

C'est moi qui vous ai enseigné les techniques de communication. Où est le feed-back ? Le feed-back doit être mutuel. Vous ne me donnez pas de feed-back.

Donc, je ne peux pas savoir si je dois expliquer plus, expliquer peut-être moins, peut-être que vous avez bien compris. J'ai besoin d'un feed-back. Alors, ce qui n'est pas objectif, ce n'est pas pathologique.

La fièvre, on peut la chiffrer. L'impotence fonctionnelle, on peut faire l'examen neurologique, on va trouver un degré. Mais une crise d'hystérie, c'est une pathologie, c'est un symptôme qui n'est pas palpable.

C'est la patiente qui le rapporte. Il y a une discordance entre ce que vous voyez comme symptôme et la réalité clinique. Donc, ce n'est pas de vraie patiente.

Il faut savoir que l'hystérie, c'est une pathologie qui date de plusieurs années. Et on a toujours, ça c'est juste pour votre culture générale, pour l'historique, pour voir quand on s'est intéressé à cette pathologie et qu'on a essayé de la décrire depuis la nuit des temps. Hippocrate a décrit ce qu'on appelle l'utérus baladeur.

Hippocrate a vu qu'il y avait des patients qui présentaient ce qu'on appelle des crises hystériques actuellement. Comment il a essayé de l'expliquer ? En fonction des moyens dont il disposait à l'époque. Il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas d'examen complémentaire.

Donc déjà, il a dit utérus baladeur. Utérus, c'est qui qui a un utérus ? C'est les femmes. Donc déjà, il a spécifié que c'est une pathologie qui est propre au sexe féminin.

Baladeur, c'est quelqu'un qui se balade ? Qui dort ? Est-ce que l'utérus se balade ? L'utérus, on sait qu'il est fixe. Oui ou non, c'est un organe fixe. À l'époque, il disait que la crise hystérique est due au fait que l'utérus se déplace au niveau de l'organisme, c'est-à-dire qu'il quitte sa position et il arrive au foie et aux hypochondres.

Et quand il arrive à cette position-là, il va entraîner de la suffocation. Le blanc des yeux se renverse, la femme devient froide, elle grince les dents et elle ressemble aux épileptiques. Sauf que ce n'est pas une crise épileptique.

Au Moyen-Âge, on a défini autrement, c'était l'âge d'eux, c'est que les patientes qui faisaient des crises hystériques, elles étaient en connivence avec le diable, c'était des sorcières. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les brûler. C'est au XIXe siècle que Charcot... Charcot, je connais Charcot, c'est un fou.

Je connais son neurologie. Je connais Charcot. C'était qui ? Pneumologue.

Il était pneumologue. Il était quoi ? Il était urologue. Donc c'est les neurologues qui ont décrit pour la première fois, c'est Charcot qui a décrit pour la première fois, qui a su en fait différencier crise épileptique, crise conversie.

Il avait décrit soigneusement les crises motrices hystériques en quatre stades. Ce n'est pas la peine de les citer. Le XXe siècle, c'est Freud.

Vous connaissez tous Freud, père de la psychanalyse, qui a décrit ce qu'on appelle la névrose hystérique. La névrose par rapport à quoi ? À la psychose. Non.

Oui. Il n'est pas conscient des symptômes. C'est la désorganisation en fait de la pensée.

Psychose, c'est une désorganisation de la pensée. La névrose, il n'y a pas de désorganisation de la pensée. Donc il a décrit bien sûr la psychose, mais surtout Freud, il est connu par la description de la névrose hystérique.

D'accord ? Pour lui, c'est une névrose structurée, c'est-à-dire c'est une pathologie qui est structurée, survenue de divers troubles somatiques. Donc déjà, il a introduit le somatique. On va voir que cette définition-là, elle tient toujours jusqu'à présent.

Ces symptômes-là peuvent être soit transitoires, soit durables. Transitoires, pour décrire quoi ? Des lésions aiguës, oui ou non ? Durables, c'est pour décrire des lésions chroniques. Sans lésions anatomo-cliniques sous-jacentes.

C'est qu'il n'y a pas d'atteinte physique ou anatomo-clinique, c'est-à-dire que l'examen clinique, les examens complémentaires sont strictement normaux. Contrairement à quoi ? Oui, vous voulez dire l'organique ? Oui, contrairement à des pathologies organiques, mais contrairement à ce qu'on appelle les troubles psychosomatiques. On va le voir comme chapitre à part entière.

Je vais introduire dès maintenant pour faire un petit peu la différence dans les troubles psychosomatiques. Il y a l'association de symptomatologie psychique ou psychiatrique avec des lésions organiques. On va voir en détail dans le cours, d'accord ? Ce n'est pas la peine de noter, mais on va voir.

Mais juste pour différencier les crises conversives des pathologies psychosomatiques, d'accord ? Dans le DSM, il y avait plusieurs descriptions. Dans le DSM 4-révisé, on décrivait les troubles somatoformes, les troubles dissociatifs, mais dans le DSM 5, il y a un changement de classification que je vais mettre. D'ailleurs, le plan de mon cours va s'axer sur la définition du DSM 5 de l'hystérie.

Mais il faut savoir que les troubles, il y a des descriptions là qu'on va voir du DSM 5. Ça fait partie de la pathologie hystérique globale, d'accord ? Assez fréquente, l'hystérie est assez fréquente, 0,5 à 2 %. Bien sûr, une prédominance féminine, on vient de le voir tout à l'heure, 2 à 5 femmes. Les premiers symptômes peuvent apparaître à l'adolescence ou à l'âge adulte jeune moins de 30 ans. Est-ce que vous avez des exemples d'étudiantes, quand vous étiez étudiante au lycée, au collège, des amis, dès qu'ils ont une mauvaise note, dès qu'il y a l'affichage des résultats du bac ou quand les enseignants donnent la note, ils s'évanouissent ? Oui ou non ? Ça, c'est des crises, ce qu'on appelle des crises conversives ou des crises hystériques.

Ça commence très tôt, dès l'adolescence. C'est un motif de consultation très fréquent, surtout en neurologie, 30 % des consultations en service de neurologie. Et on va voir pourquoi.

Parce que la symptomatologie prédominante, la symptomatologie somatique prédominante, c'est la symptomatologie neurologique fonctionnelle. On va le voir. Et 5 %, voire plus, en consultation de médecine générale, cependant, ce sont des pathologies surdiagnostiquées chez 20 à 50 % des cas des patientes de neurologie.

C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 50 % des situations où on a étiqueté une patiente comme hystérique alors qu'elle présente de réelles pathologies neurologiques. Vous voyez que c'est un surdiagnostic de ne pas prendre en charge le souci avec l'hystérie. C'est deux choses.

Soit que c'est surdiagnostiqué, et généralement on le fait pour se débarrasser de patients ou de patientes qu'on n'a pas su vraiment gérer. Soit que c'est sousdiagnostiqué et ne pas être considéré comme de réelles patientes. Et dans les deux cas, ces patientes-là, quoi que vous fassiez, elles vont vous suivre parce qu'elles vont refaire les crises à chaque fois.

Ce sont des patientes que, si vous ne les gérez pas, si vous ne les traitez pas, elles vont revenir à l'hôpital à chaque fois. Vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Donc autant bien diagnostiquer et bien traiter et prendre en charge précocement.

On va voir. Le souci avec ces patientes, c'est que quand à chaque fois vous ne les traitez pas bien, vous les vous en débarrasser, entre parenthèses, je sais que vous ne le faites pas, mais c'est une façon de parler, elles vont refaire des crises. Quand elles vont refaire des crises, l'évolution va être péjorative, c'est-à-dire qu'elles vont tomber dans la chronicité et qui va payer les conséquences, à part la patiente, bien sûr, c'est tout le système de santé.

Ce sont des patientes chronophages, c'est une surconsommation du système de soins, une

surconsommation de médicaments, et ce sont des patientes qui vont revenir vous voir parce que c'est vous le médecin. Elles ne vont pas aller voir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair ? Donc, trois grandes rubriques.

Il y a ce qu'on appelle les troubles de conversion, l'équivalent dans le DSM-5, troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Il y a ce qu'on appelle, deuxièmement, les troubles dissociatifs, et il y a la personnalité histrionique, et je crois que vous allez faire, je passerai rapidement sur le trouble de la personnalité histrionique, parce que je crois que vous allez le faire avec Professeur Menoudi. Cette répartition, comme je l'ai dit, j'ai essayé de concilier définition de l'orthographe française et DSM-5 parce que l'une complète l'autre.

Troubles de conversion, ou dans le DSM, troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle, comme le nom l'indique, ce sont les mots-clés, qui sont deux mots-clés, neurologique et fonctionnel. Neurologique pour dire que c'est des symptômes, surtout d'origine neurologique, c'est des symptômes neurologiques fonctionnels pour dire qu'il n'y a pas de lésions organiques. Pour les gens qui sont passés par la neurologie, c'est un terme qui est très utilisé par les neurologues quand ils trouvent rien à l'examen clinique ou aux examens paracliniques, ils disent que c'est fonctionnel.

Donc c'est un trouble à symptomatologie neurologique fonctionnel. Troubles de conversion, les troubles de conversion, ça veut dire quoi? Conversion, ça vient de quoi? Du verbe convertir, je dis convertir, si tout le monde comprend l'arabe. Qu'est-ce que c'est que l'arabe? Qu'est-ce que c'est que la conversion? Convertir quelque chose, convertir le roux en diramièque, qu'est-ce que ça veut dire? On transforme, on transforme quelque chose en quelque chose.

Là, quand on dit troubles de conversion, on convertit quoi ou quoi? Dans le cadre de l'hystérie. Ça je vous l'ai expliqué dans les TCA, dans les troubles des conduites alimentaires, je vous ai dit que c'est le même mécanisme qu'on va utiliser dans beaucoup de pathologies où il y a l'intrication entre le somatique et l'organique. Oui, une conversion vers le somatique.

Donc c'est une souffrance émotionnelle, psychique, et là on introduit le terme souffrance. C'est bien fait maintenant, il y a des patients qui ont des problèmes de santé, c'est bien fait, parce qu'ils ont une souffrance psychique qu'ils n'ont pas pu exprimer et qu'ils vont convertir en symptômes organiques. Donc c'est ça en fait les troubles de conversion.

C'est la conversion du psychique en symptômes organiques. C'est pour ça qu'on a dit que l'examen somatique est strictement normal. Est-ce que c'est clair? C'est tous les symptômes neurologiques que vous connaissez, mais bien sûr il y a certains symptômes qui sont plus fréquents que d'autres.

C'est des symptômes d'altération de la motricité volontaire, gardez-le bien en tête, volontaire, on va voir comment, un lèche, volontaire, ou des fonctions sensitives. Le type de symptômes, ça peut être des symptômes moteurs, des symptômes sensitifs sensoriels, des symptômes

neuro-végétatifs. Donc en fait, tous les symptômes neurologiques, moteurs, les plus fréquents c'est les paralysies, paraisies, faiblesses, asthénie, etc.

GER-CHLN. Donc l'examen clinique est strictement normal. Ça peut prendre la forme de tétraplégie, d'hémiplégie, alors que l'examen est normal.

Il y a ce qu'on appelle aussi les crises psychogènes non-épileptiques, c'est des crises qui sont semblables à des crises épileptiques, c'est la même chose, sauf que le GER est normal, et l'examen neurologique est normal. Le souci aussi avec les crises psychogènes non-épileptiques, c'est que parfois, il ne faut pas trop se fier à un EG normal face à une crise épileptique, parce que dans des situations fréquentes, quand on refait l'EG, et avec l'évolution, on se rend compte que c'était de vraies crises épileptiques. Surtout dans les crises épileptiques d'origine psychogène, il ne faut jamais conclure à ce diagnostic précocement.

Il faut refaire l'EG à chaque fois pour être sûr, parce que l'épilepsie, c'est une pathologie assez grave. Les troubles sensitifs ou sensoriels, hypoesthésie, anesthésie, hyperesthésie, algie, atteinte auditive, visuel, cécité, cécité est très fréquente, on a vu plusieurs cas de cécité d'origine psychogène, d'origine conversive. Les troubles neurovégétatifs, nausées, vomissements, coliques, dysphagie, dysurie, vaginisme, précordialgie, et le symptôme aussi le plus parlant, le plus spectaculaire, c'est les épisodes d'inconscience, que je vous ai décrits tout à l'heure, qui ressemblent à des syncope ou à des coma, alors que l'examen, quand on a dit l'examen somatique, les constantes sont normaux.

L'interdiagnostic, DSM-5, c'est ce qu'on vient de décrire tout à l'heure. C'est un ou plusieurs symptômes d'altération de la motricité volontaire ou des fonctions sensitives. Le critère B, c'est juste pour dire que, le critère B c'est que l'examen neurologique est normal, l'examen somatique est normal, et que ça ne répond pas à la description d'une pathologie organique.

Le critère de DSM correspond toujours aux conséquences de la pathologie. Pour parler de trouble ou pathologie, c'est qu'il doit y avoir des conséquences négatives sur l'état psychique, sur le fonctionnement du patient, à secours de la souffrance, à secours des conséquences négatives. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les critères de DSM-5, parce que je n'en ai pas besoin.

Le DSM-5, c'est juste un résumé de ce qu'on vient de voir. Excusez-moi. Les types de symptômes.

Deux manifestations aiguës. Les manifestations aiguës, c'est la crise. Il y a deux types de manifestations.

Les manifestations aiguës et les manifestations chroniques. Les manifestations aiguës, c'est la grande crise d'agitation qu'on appelle la grande crise de charcot, avec une décharge émotionnelle théâtrale. Est-ce que vous avez déjà vu une crise hystérique ou la crise conversive

typique? Il y a des gens qui sont emmenés à l'hôpital par la famille, soit dans la rue, oui ou non.

Personne. Comment on peut décrire? C'est une grande crise d'agitation. La patiente, elle crie.

C'est une expression émotionnelle théâtrale. C'est ça, la grande crise de charcot. Elle est très spectaculaire.

Vous la voyez une fois, vous ne l'oublierez jamais. D'accord? Il y a des crises tétaniformes, comme les crises de tétanos. Les crises syncopales ou les lipotémies, c'est aussi parmi les crises les plus fréquentes, où il y a une perte de connaissance.

Les crises d'allure convulsive, c'est-à-dire qui ressemble aux crises convulsives ou crises épileptiques. Et les crises pseudo-comateuses. Les manifestations chroniques, ce sont des manifestations durables, avec des atteintes fonctionnelles partielles ou totales.

Avec la douleur, crise conversive avec de la douleur. Quels sont les caractéristiques des douleurs conversives? Il faut savoir qu'il y a plusieurs caractéristiques qui vont nous faire différencier une douleur conversive d'une douleur qui est due à une pathologie, une pathologie organique. La douleur représente 70% des troubles conversifs.

Elles peuvent se faire sous forme de douleurs, par esthésie, hyperesthésie, douleurs articulaires, les céphalées. La douleur, quel que soit le type de douleur, représente 70% des crises conversives. Les douleurs sont des manifestations chroniques ou durables de l'hystérie.

Elles ont une expression théâtrale. Je nous mène à une expression théâtrale. Fleu théâtre, je ne sais pas.

Je pense qu'on dit fleu théâtre. Oui, on doit attirer l'attention des spectateurs en exagérant nos mimiques, en exagérant notre comportement. Je dois avoir une hyper-mimique pour que les gens puissent réellement voir que je suis en train de pleurer, que je suis triste.

C'est ça l'expression théâtrale, c'est que la patiente exagère la douleur. Vous l'avez déjà décrit dès le départ, c'est des patientes qui ont tendance à exagérer, c'est l'expression théâtrale. Ironiquement et paradoxalement, c'est des douleurs qui s'en continuent, mais qui ne perturbent pas le sommeil.

C'est une patiente qui peut dormir tranquillement alors que toute la journée elle se plaint de douleur, elle se tourne de douleur et elle crie, mais quand elle dort, ça ne dérange pas. Contrairement, bien sûr, à une douleur articulaire d'origine rhumatismale, d'origine décephalée qui ne cesse pas lors du sommeil. Le sommeil n'est pas perturbé par ce genre de symptômes.

C'est la première caractéristique la plus importante. La deuxième caractéristique la plus importante, c'est des douleurs résistantes à tout traitement médical symptomatique. Si c'est décephalée, ça ne répond pas au doliprane.

Si c'est des douleurs articulaires, ça ne répond pas aux anti-inflammatoires ou aux onalgiques usuelles, d'accord? Et qui causent une importance fonctionnelle importante, apparente bien sûr. C'est que c'est une patiente qui n'arrive pas à marcher, la famille va le ramener avec une chaise roulante, etc. Mais gardez en tête que les douleurs ne perturbent pas le sommeil, ne sont pas améliorées par les onalgiques et qui ont une expression théâtrale.

Les troubles dissociatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, dissociatif pour dire que c'est des symptômes psychiques. Quand on a parlé de conversion, on avait dit que c'est la conversion du psychique, la souffrance psychique vers l'organique, en symptômes somatiques.

D'abord, les troubles dissociatifs sont des symptômes psychiques. À votre avis, comment on pourrait gérer une souffrance psychique psychiquement, sans avoir à faire une conversion? En se dissociant dans le temps, comme vous avez dit, dans l'espace, d'accord? Et on va le voir en termes de symptômes. Gardez en tête que les troubles, les symptômes, pardon, les symptômes ou troubles dissociatifs sont des symptômes psychiques.

Les symptômes neurologiques, fonctionnels, des symptômes organiques, mais si vous la prenez en termes de conversion, symptômes conversifs, c'est que c'est une conversion de la souffrance psychique en symptômes organiques. Là, c'est une dissociation psychique de la souffrance dont la personne souffre, de la souffrance de la personne, pardon. Voilà.

En définition, c'est une altération soudaine et transitoire des fonctions normales d'intégration de la conscience, de l'identité et du comportement moteur. Alors, je dis intégration de la conscience, c'est une altération soudaine et transitoire des fonctions normales d'intégration de la conscience, intégration de l'identité, intégration du comportement moteur. Intégration de la conscience, c'est que je suis consciente de moi, que je suis là, je m'appelle Adélie, je suis dans l'amphi, et oui, je sais que c'est l'amphi, je sais que c'est les étudiants, je suis consciente de mon identité, je suis consciente dans le temps, je sais qu'il est, c'est l'après-midi, c'est déjà 14h51, on est le 12 peut-être, je sais que globalement on est au mois de septembre, oui ou non.

Donc c'est ça en fait l'intégration. Et c'est que j'intègre aussi mon comportement moteur, s'il vous plaît. Donc je sais que là je suis en train de marcher, je sais que je suis en train de parler, d'accord.

C'est ça en fait l'intégration. C'est comme la définition. L'intégration de notre conscience, je suis consciente de qui je suis, de où je suis et de mon identité.

Il y a des situations où on n'a plus cette intégration de ces éléments-là. On va voir comment. Dans le DSM, il y a ce qu'on appelle dépersonnalisation, déréalisation.

Je ne sais pas comment dire ça. Dépersonnalisation. Dé, je ne sais pas comment dire dé.

Préfixe, je ne sais pas comment dire ça. Suppression. Dépersonnalisation, on peut dire que c'est

qu'il n'y a plus de personnalité.

On n'est plus conscient de sa propre personnalité. Comment? C'est une expérience d'irréalité. On sent que c'est irréel.

De détachement, qu'on devient un observateur extérieur de sa propre pensée, de ses propres sentiments, des sensations, de son corps et de ses actes. Elle dit il y a la dépersonnalisation. On va la décrire, mais il faut la vivre pour comprendre ce que c'est.

Je me vois comme étant un observateur externe. Je suis là, mais je vois qu'Imane Adeli est en train de faire le cours. Je suis tout à fait étrange à Imane Adeli.

Je suis là, je suis en train de la voir. Je suis en train de faire le cours. Imane Adeli est en train de faire le cours.

Moi, je suis un observateur externe. Je sens que c'est irréel. Ce n'est pas moi qui suis en train de faire le cours.

C'est une autre personne. Je suis en train de l'observer. C'est ça la dépersonnalisation.

D'accord? Il faut savoir que la dépersonnalisation des réalisations, on peut l'avoir dans plusieurs pathologies. Trouble, panique. On vous a décrit la dépersonnalisation des réalisations comme étant corps.

Comme étant comment? Pardon? Un mot de? Non, je ne parle pas du mécanisme. Comme une expérience très douloureuse, très angoissante pour les patients. Beaucoup de patients peuvent faire des tentatives de suicide quand ils sont en dépersonnalisation des réalisations.

C'est une sensation très angoissante. Le deuxième symptôme, c'est la déréalisation. Dé, bien sûr.

Réalisation, c'est la réalité. C'est une expérience d'irréalité aussi, où cette fois-là, c'est un détachement du monde extérieur. C'est que je suis là, mais j'ai un sentiment d'étrangeté.

Je vois l'amphi déformé. Je vous vois, vous êtes là. Vous me paraissez bizarre, déformé.

Pas comme la normale. Pas comme la réalité normale. Les personnes sont perçues comme irréelles.

Comme si j'étais dans un rêve. Vous êtes sans vie, ou vous êtes visuellement, c'est plus fréquent, visuellement déformé. Je vous vois déformé.

Je vois l'amphi déformé. La fac est bizarre. Il y a quelque chose qui se passe.

Je suis comme si j'étais dans un rêve. C'est ça le sentiment de déréalisation. Ce sont deux

symptômes qui sont très angoissants chez les patients.

Deuxièmement, l'amnésie dissociative. Amnésie, c'est l'incapacité de se rappeler de l'information, de certaines informations autobiographiques importantes. On peut décrire l'amnésie localisée, l'amnésie sélective et l'amnésie généralisée.

L'amnésie localisée, elle concerne des événements localisés dans le temps. Par exemple, quand vous avez des patients qui ont subi des traumatismes sexuels, par exemple à l'enfance. Comme moyen de défense, comme vous l'avez bien dit, de défense psychique, les patients vont choisir.

Quand je dis choisir, c'est très schématique. Tout se passe dans l'inconscient des malades. Notre inconscient peut choisir d'oublier les événements qui ont été, c'est-à-dire l'événement traumatisant, avec tout ce qui vient dans les mois qui ont précédé ou dans les mois qui ont suivi.

Il y a l'amnésie localisée, c'est-à-dire qu'elle est localisée dans le temps. Je n'oublie pas toute mon autobiographie, mais j'oublie un élément, un bout de temps de mon autobiographie. Généralement, la partie que j'oublie, elle est en rapport avec l'événement traumatisant.

L'événement traumatisant se trouve dedans. Dans l'amnésie sélective, c'est que je choisis d'oublier une partie de l'événement traumatique. On a des patients que, quand on prend en charge des patients pour des traumatismes psychiques, certaines maladies, ils oublient, supposons que c'était une agression physique.

Quelqu'un qui vous a agressé dans la rue, quelqu'un a agressé le patient ou il l'a poignardé. Ça, c'est l'événement traumatique. Le patient peut inconsciemment choisir d'oublier une partie de l'événement traumatique, c'est-à-dire que, quand vous lui dites ce qui s'est passé, il peut vous rapporter, dans les situations normales, il va vous rapporter l'événement traumatique du début à la fin.

J'étais dans la rue, j'ai fait ça, il a fait ça, il m'a poignardé, il a pris... Mais dans les situations où ça déborde notre capacité psychique, le malade peut se rappeler d'une partie de l'événement, peut se rappeler du visage de l'agresseur, il peut se rappeler de la partie où il a été poignardé, il peut se rappeler du fait qu'il marchait dans la rue, dans une rue sombre. Le reste de l'événement, on l'a fait abstraction. On sélectionne une partie de l'événement traumatique.

L'amnésie généralisée, elle est rare, on la voit dans les films. Les films coréens, les films américains, les films égyptiens, c'est très caricatural, ça existe, mais c'est très rare qu'on oublie tout. Les personnes oublient leurs noms, leurs prénoms, d'où ils viennent, bien sûr suite à un événement traumatique.

C'est très rare, c'est une perte complète de la mémoire qu'on voit dans les traumatismes graves, assez graves. Traumatismes de guerre, les agressions physiques ou sexuelles très graves qui mettent en danger le patient. On la voit chez les anciens combattants, au cas d'agressions

sexuelles, etc.

Oui, généralisée, oui. Non, il ne faut pas perdre le langage. C'est juste une amnésie.

C'est un symptôme. Pourquoi vous avez parlé de perte de langage ? Il oublie tout, oui. L'amnésie, c'est l'incapacité de se rappeler les informations autobiographiques.

Quand on ne parle plus, on ne sait plus comment parler. C'est une attente neurologique, en fait. Ce n'est pas une amnésie.

On n'oublie jamais comment parler, parce que le fait de parler, on l'acquiert. C'est une capacité cognitive qu'on a déjà acquise. L'amnésie, ça concerne les événements autobiographiques.

Je dis autobiographiques, les événements de vie. Le nom, prénom, c'est qui tes parents, c'est qui tes grands-parents, tu habites où. C'est ça, c'est la biographie de la personne.

Quand on oublie, c'est qu'on oublie tout. On oublie notre nom, on vient d'où, notre adresse, si on est marié ou pas, etc. C'est très rare.

C'est des situations qui sont très rares. On la voit beaucoup dans les films, mais dans la réalité, heureusement, ce sont des situations rares. La fugue dissociative, c'est une fugue suite à un événement traumatisant qui est associé à une amnésie, soit de son identité, soit d'autres informations autobiographiques importantes.

Moi, je n'ai jamais vu une fugue dissociative. En fait, on avait le doute entre une fugue dissociative post-critique, c'est-à-dire post-crise épileptique, et je veux faire avec vous le cours des troubles psychiques dans l'épilepsie, et entre fugues dissociatives. Parce qu'on avait un patient qui a conduit, je crois, de Marrakech à Ben Gurir.

Il a laissé, dans le cadre d'une, on va dire, une fugue dissociative par extrapolation. Dans le cadre d'une fugue dissociative, il a conduit de Marrakech à Ben Gurir. Il a laissé sa voiture en autoroute et il a erré dans la ville.

On nous l'a ramené dans un état d'instabilité, de propos incohérents, etc. Et quand on a vu le malade, on ne savait rien de lui. Le malade ne se rappelait ni de son nom, ni de son prénom, ni de rien, en fait.

Et là, on avait le doute entre une pathologie organique, notamment. Ça, on peut le voir aussi, l'amnésie ou la fugue dissociative, on peut la voir dans l'épilepsie, en post-critique. Quand un patient fait un état de mal, il peut faire une fugue dissociative.

Ce patient-là, il a bien conduit. Comment il a conduit ? Il a conduit de façon automatique. Donc, les skills ne s'oublient pas dans l'amnésie.

L'amnésie, c'est les événements autobiographiques. Ce n'est pas la capacité, par exemple, de

conduire. Donc, c'est un patient, en fait, quand on a fait le G, après la famille s'est présentée, on a su qu'il y avait des anomalies critiques, etc.

Donc, on a su que c'était un état de mal épileptique. Mais nous, on avait le doute entre ces deux diagnostics-là. C'est très rare, heureusement.

Et c'est très dangereux, parce que ce patient-là, il pouvait se mettre en danger ou bien mettre en danger la vie des autres, parce qu'il a conduit à 120 km, peut-être plus, flotte aux routes, alors qu'il était en fugue dissociative, il était en amnésie totale. D'accord? Heureusement que, comme je dis, c'est rare. Les troubles dissociatifs de l'identité.

Personnalité multiple. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand je dis personnalité multiple? Split. Split.

Alors, qu'est-ce qui caractérisait, si on veut résumer le film, qu'est-ce qui caractérisait la personnalité, excusez-moi, principale du film? Qu'est-ce qui caractérisait cette personnalité? Des traits. Plusieurs personnalités, mais je dis des traits. Personnalité.

Il y en a la femme, il y a le monstre, the beast, donc il y avait plusieurs personnalités associées. Ces personnalités étaient comment? Très différentes. Et l'une veut prendre le dessus sur l'autre.

Elle dit la caractéristique des personnalités multiples. Moi, je n'en ai jamais vu. C'est un diagnostic très rare.

Il y a certaines personnes aussi, certains psychologues et psychiatres qui remettent en question l'existence réelle des personnalités multiples. Rien que pour l'histoire. Avant de vous parler de l'historique des personnalités multiples, c'est soit ça, de façon spectaculaire, soit les patients rapportent lors du passage d'une personnalité à une autre, comme s'ils avaient une expérience de possession.

Comme s'ils étaient possédés. Et avec une amnésie dissociative. Vous voyez que quand le patient, quand le personnage principal passait d'une personnalité à une autre, est-ce qu'il se rappelait de ce qu'il a fait? Non.

Vous pouvez voir des patients qui décrivent des amnésies qui décrivent qu'ils ont senti une grande fatigue en se réveillant, par exemple, qui pensent qu'ils sont possédés, alors que c'est des personnes qui ont des personnalités multiples qui prennent le dessus. À chaque fois, le patient, la personnalité principale, ne se rend pas compte de l'existence des autres personnalités. Je n'en ai jamais vu, comme je vous l'ai dit, très peu de personnes ont déjà vu ça.

Ce n'est pas très fréquent. Il y a des psychiatres, comme je vous l'ai dit, qui remettent en question l'existence de ces personnalités multiples. La première fois que ça a été décrit, c'était par une psychologue chez une femme qui avait plusieurs personnalités.

Elle avait fait des entretiens avec elle, enregistré, audio enregistré. Elle avait plusieurs personnalités et là, c'était quelque chose d'important au domaine de la psychiatrie. Mais rapidement, ça a été réfuté par plusieurs psychiatres de renommer en disant que la psychologue, elle avait suggéré à sa patiente, lors de l'entretien, l'existence de ces personnalités multiples.

On va voir que ils ont en partie raison parce que dans l'hystérie, les patientes sont susceptibles à la suggestion. Je trouve qu'elles sont susceptibles à la suggestion. Facilement influencées.

Exemple simple. Quand vous avez une patiente qui a fait sa crise. On va le voir.

J'anticipe dès maintenant la prise en charge. Quand elle est, par exemple, dans la rue, les gens vont se mettre à dire quoi ? «Skina !» «Kasrera !» «Oh, la pauvre !» «Murat Smech !» Quand on va entendre ça, qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va foncer encore dans... Elle va prolonger le trouble. Ce sont des patientes qui sont suggestibles.

Facilement suggestibles. Cette psychologue-là, elle avait, bien sûr, fait entrer les personnalités multiples dans la catégorie hystérique dès le départ, bien sûr, c'était clair. Sauf que, quand j'ai dit les autres psychiatres, ils ont entendu l'entretien, ils ont vu les manuscrits, ils ont dit que non, il y a un problème parce que cette personne-là, elle avait suggéré.

Et ça a été archivé. Après, cette split, c'était pas ça. Mais c'était inspiré du premier entretien qui a été fait avec une personne qui a des personnalités multiples.

Ça a été archivé, on n'en a plus trop parlé jusqu'à ce que, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'est un journaliste ou un psychologue qui avait fait sortir ces enregistrements-là. Et le dossier médical de la patiente qui était d'ailleurs, je crois, décédé. Et cette patiente-là, elle avait la caractéristique, elle avait le don du dessin.

C'était une personne qui aimait beaucoup dessiner. Ils ont analysé, bien sûr, encore une fois, le manuscrit et les enregistrements audios, mais aussi les dessins de la patiente. Ils ont donné, de façon anonyme, à un expert, un professeur en dessin ou un expert, pour analyser ces dessins-là.

Et cette personne-là, il avait affirmé que ces dessins proviennent au minimum de 12 personnes différentes. Donc là encore, alors que la psychologue, je crois qu'elle avait décrit neuf ou dix, je ne me rappelle pas, pour ne pas dire des bêtises. Là encore, c'est juste pour l'anecdote, là encore, dissociatif de l'identité, personnalité multiple, grand point d'interrogation.

Ça existe ou ça n'existe pas, je ne peux pas vous dire. D'accord ? La personnalité, la personnalité hystérique, bien sûr, vous allez le voir dans le cadre du cours des troubles de la personnalité, c'est un histrionisme ou un théâtralisme. C'est une patiente qui a la volonté de plaire, de séduire, une grande séductrice, la personne qui a un trouble de la personnalité hystérique, c'est une grande séductrice qui aime s'accaparer l'attention, suggestible, là je crois que vous avez compris c'est quoi, c'est-à-dire en fonction de l'auditoire, en fonction de la

personne qui est en face, elle peut changer sa façon de parler, elle peut changer son comportement, en fonction aussi des circonstances pour plaire à son interlocuteur.

Elle est attirée par la perfection, tout doit être parfait chez elle, surtout côté physique. Ce sont des personnes qui ont une tendance à la dramatisation de tout ce qui se passe et qui ont une hyper réactivité émotionnelle, c'est-à-dire même au niveau émotionnel, c'est exagéré. Ils expriment de façon exagérée leurs émotions, intolérance à la frustration, c'est des patientes facilement irritables qui ont une labilité de l'humeur qui passent par des crises de larmes très exagérées et des colères spectaculaires.

C'est tous les symptômes qu'on avait vus mais un minimum et qui constituent un trouble de la personnalité hystérique. Généralement, il faut savoir que de façon générale, les crises conversives surviennent sur un fond d'un trouble de la personnalité hystéronique. Quand c'est associé, ça rend la prise en charge très difficile parce que les troubles de la personnalité de façon générale, elles sont difficiles à traiter.

Ils nécessitent une prise en charge psychothérapeutique au long cours. Le but n'est pas de guérir la personne du trouble de la personnalité mais de la stabiliser et de prévenir les complications des troubles de la personnalité. Vous allez le voir, je crois, en détail avec Professeur Menoudi.

Ce sont des patients qui ont une dépendance affective. Ils recherchent la valorisation. Ils sont parfois immatures.

Ils sont toujours en quête de réassurance et qui ont des troubles sexuels. Contrairement à une séduction apparente, c'est des personnes qui sont hyper séductives mais ce n'est pas des personnes qui ont une hypersexualité. Au contraire, elles ont de réels problèmes sexuels.

À l'entretien, pour faire le diagnostic, vous l'avez bien dit, on cherche dans les antécédents de la patiente les antécédents de conversion hystérique. Est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de faire des crises hystériques? Est-ce que c'est une patiente qui a l'habitude de faire des consultations médicales fréquentes en médecine générale pour des symptômes somatiques? Est-ce qu'il y a l'émotion de troubles sexuels? Bien sûr, quand on cherche les premiers symptômes, vous le savez bien, ça débute avant l'âge de 30 ans, et que le symptôme actuel pour lequel la patiente consulte, il est survenu généralement suite à un stress psychologique ou physique. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup de patients qui ont été, à part après le mort du séisme, ou là juste après le séisme, à part les personnes qui ont été sidérées par la peur, c'est une réaction normale de la peur, beaucoup de patients, qui ont fait des crises conversives sous forme de on dirait de troubles de la marche, d'hémiplégie, c'était des conversions qui n'ont pas pu bouger.

Je ne parle pas, comme j'ai dit, de la sidération due à la peur. Parce que face à la peur, les gens peuvent avoir des réactions différentes. Il y a fight, soit une réaction de sidération, une réaction de fuite, soit une réaction de vous vous affronter.

Donc, chaque personne a sa réaction à elle face à un danger. Généralement, c'est une réaction que vous allez garder pendant toute votre vie. Surtout, quand on est face à des situations comme ça, imprévisibles, où on voit la mort, on frôle la mort, chacun de nous a sa propre réaction face à un événement traumatisant.

D'accord ? Donc, on avait dit que c'est des patients qui présentaient de la symptomatologie actuelle suite à un traumatisme récent qui survient lors de certaines périodes critiques dans la vie d'une personne, l'adolescence, milieu de vie, licenciement, retraite, et qui sont présentés de manière dramatisée par le patient dans une belle indifférence. Pardon ? L'émotion ? L'indifférence par rapport à quoi ? Imaginons que c'est une personne qui présente une cécité d'origine convergée. La cécité, c'est quelque chose de très grave.

La patiente va vous rapporter ça de façon dramatisée. « Non, mon Dieu, j'ai perdu la vision » qui va prendre en charge la dramatisation, bien sûr. Mais c'est une patiente qui est tout à fait indifférente par rapport à quoi ? Par rapport à l'origine de ce trouble.

Quand quelqu'un présente une cécité ou quand il présente une hémiplégie, il voudra bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est une pathologie neurologique ? Est-ce qu'il ne fait pas un cancer ? Mais les patients antihystériques ne vous posent jamais la question sur ce que vous avez trouvé à l'examen clinique, de quoi je souffre, pourquoi j'ai fait ça. Ils vont exagérer, dramatiser le symptôme en lui-même sans pour autant être angoissé, l'indifférence par rapport à l'origine.

Mais pourquoi j'ai fait une hémiplégie ? Une hémiplégie, ça ne court pas les rues, c'est grave, donc je dois savoir pourquoi. Bien sûr, altération du fonctionnement social et professionnel, c'est clair. Examen somatique organique normal, et bien sûr avec une fréquence d'écomorbidité psychiatrique, notamment la dépression et les troubles de la personnalité, notamment histrionique.

Il y a des formes monosymptomatiques, c'est juste pour dire que formes avec un seul symptôme qui est un seul organe qui est rapporté par la patiente, généralement c'est des algies, c'est tout ce qui est douleurs lombaires. Les femmes qui se plaignent souvent de douleurs lombaires, douleurs rachidiennes, d'accord ? Des formes polysymptomatiques avec des symptômes multiples. Il y a la forme aussi de l'homme, généralement c'est une forme monosymptomatique, très rare, je n'en ai jamais vu.

Non, si, j'ai déjà vu, mais en fait je n'ai pas vu une forme monosymptomatique chez l'homme, mais j'ai vu une forme identique à la forme classique chez la femme, avec un théâtralisme, c'était très rare, mais j'ai déjà vu un seul cas que j'ai d'ailleurs tardé à diagnostiquer comme trouble de la conversion, avec des symptômes somatiques très fréquents, toujours de théâtralisme, de dramatisation, etc. C'était en fait la forme classique chez l'homme. La forme collective, qu'est-ce que ça veut dire ? Paranoïa, paranoïa, isawa, oui ou non ? Ça finit par quoi ? Qu'est-ce qui se

passer normalement quand il y a isawa, gnawa ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe généralement ? La musique commence, il y a une meneuse qui commence, puis après, tout le monde commence à faire la même danse, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? C'est comme ce qu'on appelle chez les Égyptiens.

Même les Égyptiens, ils le font. Quand ils suspectent que quelqu'un est malade, qu'il est possédé par le genou, etc. C'est la même chose.

C'est ça l'aspect culturel. Quand une personne fait une crise convulsive, les autres, mais qui va faire réellement les crises convulsives ? Quand on parle de l'aspect culturel, si nous, on commence, on veut faire gnawana, supposons que je suis la meneuse, je vais commencer à danser, et qui va me suivre ? Oui, je sais que c'est les femmes, mais je vous ai dit que je viens de voir un cas de... Mais qui va me suivre ? Qui va faire la même chose ? C'est les personnes, pas les isthétiques, mais les personnes suggestibles et vulnérables. Les personnes qui ont le même trouble que moi.

Est-ce que c'est clair ? Mais c'est quoi l'offre de l'enfant qui va dire des crises convulsives ? C'est les personnes, bien sûr, qui sont aussi vulnérables, qui ont soit un trouble de la personnalité histrionique, soit qu'ils sont connus en faisant des troubles convulsifs, etc. Est-ce que c'est clair ? Et aussi, les crises convulsives, on les voit siffler dans les situations, peut-être que ça vous l'avez vu, vous l'avez vu certainement, dans les situations de deuil, pas de deuil, mais lézard, le jour de lézard. J'ai déjà vu des femmes qui pleurent et qui font... C'est à la limite de l'agitation.

Vous avez déjà vu ça ? Ça aussi, c'est une exagération des symptômes. Si on veut l'analyser de façon scientifique, d'après ce qu'on a vu, c'est une expression théâtrale, oui ou non, suite à quoi ? Un événement traumatisant qui est le décès, que ce soit d'un voisin, du père, de quelqu'un de proche ou même de loin, qui est un événement traumatisant, qui est une souffrance. Il y a l'aspect dramatique, il y a l'aspect théâtral, il y a l'agitation, et généralement, cette personne-là qui était en train de pleurer, elle va finir par faire quoi, généralement ? Par une perte de connaissance.

Ça, c'est typiquement... Heureusement que c'est les personnes qui sont vulnérables, suggestibles, qui ont des troubles d'impersonnalité trioniques, qui vont faire ce genre de comportement ou de crise. Est-ce que c'est clair ? Pourquoi les patientes vont me faire des crises ? Quelle est la signification du symptôme hystérique ? Vous le savez tous, maintenant, il y a ce qu'on appelle le bénéfice primaire. Le bénéfice primaire, c'est que ce symptôme, que ce soit un symptôme dissociatif ou là un symptôme convulsif, c'est un mécanisme de défense du psychisme face, comme on l'a dit, à une souffrance importante.

Oui ou non ? Le bénéfice primaire, c'est un bénéfice personnel, c'est un bénéfice psychique, disons psychique. Pour dire qu'en tant que mécanisme de défense névrotique, je viens de l'expliquer en trois mots. C'est un mécanisme de défense face à une douleur trop importante.

Le bénéfice secondaire, le bénéfice secondaire, c'est qu'est-ce qu'elle attend, la patiente, qu'est-ce qu'elle attend de la crise, du symptôme hystérique ? C'est des avantages inconsciemment. Je l'ai mis en gras et je vais le souligner trois, quatre fois, mille fois. C'est des avantages inconscients.

Les bénéfices secondaires de l'hystérie sont des avantages inconscients attendus par le symptôme, tel que le réaménagement familial, du travail, évidemment de la responsabilité de conflit, etc. Supposons la femme-là, la dame-là, votre exemple, monsieur, qui a des conflits avec son mari et se dispute, peut-être même qu'il la frappe, d'accord, qu'à chaque fois qu'elle fait cette perte de connaissance, le mari, il devient attentionné, il y a la famille qui vient qui s'inquiète pour elle, la belle famille qui vient, qui s'inquiète pour elle. Il y a sa maman qui reste avec elle pendant toute la durée de convalescence, entre parenthèses, pour l'aider dans les travaux ménagers, et le mari, il devient attentionné, il devient gentil.

Alors, ce symptôme-là, en fin de compte, il a servi à quelque chose, oui ou non? Donc, Hadouma, les bénéfices secondaires. Qu'est-ce que le symptôme apporte à la patiente et qui va faire que cette patiente va refaire inconsciemment, inconsciemment, le même symptôme à chaque fois qu'elle est en situation de souffrance. Au début, c'était à cause du conflit avec le mari.

Après, ça peut être quand j'ai un conflit avec la voisine, quand je suis devant une situation stressante. Donc, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est important de les décrire parce que dans la prise en charge psychothérapeutique, on va travailler sur les bénéfices secondaires.

On doit démontrer à la patiente qu'elle peut gérer ses problèmes émotionnels de façon différente que par les bénéfices secondaires. D'accord? Donc, l'analyse, quand on fait l'entretien avec la patiente, quand on fait l'analyse, quand on fait l'anamnèse, on cherche toujours les bénéfices secondaires et on les met de côté pour les travailler en travail psychothérapeutique. D'accord? La belle indifférence, on l'a expliqué.

Le choix du symptôme, je termine et puis je prends votre question. Le choix du symptôme, il est fait surtout par rapport à ce qu'il symbolise. Je vous donne un exemple.

On avait dit que les symptômes neurologiques de la convergence et des symptômes de la motricité sont parfaitement inconsciemment plausible dans ce genre de situation, oui ou non? Elle lèche l'hémiplégie, parce que qu'est-ce qui va me permettre d'aller chez toi? Mes pieds, oui ou non? Donc autant faire une hémiplégie. La société, je vois des choses, mes enfants se disputent toujours, mes filles ne font pas le ménage comme je veux, ma maison est sale, je n'aime pas ça, je n'aime pas trop ça. Donc qu'est-ce qui serait mieux comme symptôme qui pourrait m'arranger? Je parle toujours de façon inconsciente.

Une société, elle m'échappe, elle mange, est-ce que c'est clair? Donc le choix du symptôme aussi, il a une forme symbolique, c'est-à-dire que ce symptôme, de par ce symptôme-là, j'ai des bénéfices secondaires, mais aussi, je ne veux pas aller te voir, je ne vais pas faire des troubles sensitifs. Je ne suis pas folle d'une hémiparésie, autant faire une hémiplégie, est-ce que c'est clair? Quand je dis faire, c'est très schématique, ça ne se passe pas de cette façon-là qui est facile et qui est caricaturale, non. C'est très complexe au niveau psychique, mais je vous parle de façon très schématique pour vous rendre les choses faciles, d'accord? Oui, votre question, rapidement.

Elle ne va pas chercher? Non, elle n'est pas intéressée par l'origine du symptôme. Ce qu'on est intéressé par l'origine du symptôme pour être guéri. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas de guérir, c'est d'écrire de façon caricaturale, théâtrale, le symptôme.

Par contre, ce qui va retarder ou inhiber la prise en charge chez la patiente, c'est les bénéfices en fait secondaires. Parce que si je n'ai plus ce symptôme-là qui me permet d'avoir des bénéfices secondaires, comment je vais traiter mes problèmes avec mon mari? D'accord? Donc, je ne dois pas me débarrasser ou la guérir ou améliorer le symptôme. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le travail psychothérapeutique, c'est en apprenant la patiente de régler ses problèmes, ses conflits psychiques et relationnels de façon différente pour justement ne pas sentir le besoin d'avoir les bénéfices secondaires, d'accord? Le but du symptôme, bien sûr, vous l'avez compris, excusez-moi, c'est de séduire, attirer l'attention à une souffrance, manipuler.

Manipuler qui? Manipuler l'agresseur, agresser l'agresseur en fonction de ce que je vois. L'agresseur qui peut être le mari, qui peut être la voisine, qui peut être le boss au travail, etc. Faire souffrir la personne qui m'a fait souffrir ou l'entourage, mon entourage, qui ne me comprend pas, je veux le faire souffrir.

Tout ça, c'est de façon inconsciente. Je le dis et je le redis. Touche les fonctions de la vie de relation.

On vient de le comprendre. La vie de relation, c'est les pieds pour aller vous voir, les mains pour vous saluer, les yeux, par exemple, pour vous voir. Bien sûr, atypique, ne respectons pas de lésions anatomocliniques particulières.

Bien sûr, parce que l'examen, comme on a dit, l'examen somatique, il est normal. L'évolution sensible à la suggestion, aggravée par les émotions. Dès qu'il y a, s'il vous plaît, un facteur de stress psychique, il y a l'aggravation des symptômes, extension des troubles, c'est-à-dire on peut aller de la forme monosymptomatique, si ce n'est pas traité, à la forme polysymptomatique, bien sûr avec des conséquences sociales et des complications psychiatriques, notamment dépressives, les tentatives de suicide et les comportements, surtout les comportements d'addiction, les conduits addictifs.

Et bien sûr, on l'a vu dès le départ, dès l'introduction du cours, c'est que les crises hystériques, c'est une surconsommation d'actes médicaux et de médicaments et de temps aussi du médecin. Les théories, je passerai. Par contre, les diagnostics différentiels sont importants.

Vous pouvez les déduire vous-même. Tout ce qui est affections organiques, l'élément contre, c'est l'examen somatique où on trouve des lésions. Les maladies psychosomatiques, on va le voir.

Je vous demande de faire abstraction. Et la simulation, le souci avec les crises convulsives ou dans l'hystérie, c'est qu'en milieu carcéral, en milieu militaire, ils sont toujours devant la problématique de patients qui font des crises convulsives ou là, qui simulent. Parce que le but de la simulation, par exemple, en milieu militaire, c'est quoi ? C'est avoir de la décharge, une décharge du système militaire.

Et c'est là la difficulté aussi de faire le diagnostic différentiel. C'est un diagnostic qui est minutieux. On doit chercher aussi quels sont les bénéfices conscients de la personne par rapport à la maladie simulée.

L'hypochondrie, c'est la peur d'avoir une maladie grave. Sauf que dans l'hypochondrie, l'élément contre, c'est que les personnes cherchent à trouver l'étiologie de la maladie. Il n'y a pas la belle indifférence.

Un patient hypochondriaque, il craint qu'il ait un cancer. Il va faire tous les bilans. L'hypochondriaque régit une tonne de bilans.

Il a vu tous les médecins possibles et imaginaires. Et certaines pathologies psychiatriques dans lesquelles on peut trouver des symptomatologies douloureuses, des symptomatologies somatiques, notamment les douleurs, les paresthésies, notamment la dépression et les troubles anxieux. Les règles générales.

Première recommandation en tant que médecin généraliste, le traitement pris en charge par le médecin généraliste aux urgences. Première recommandation, le somatique prime. Examen clinique complet.

Les examens paracliniques en fonction de ce que vous suspectez, pas en exagération. L'annonce du diagnostic, vous avez fait tout ce qui est possible, imaginaire, vous avez éliminé l'organique. Là, vous allez annoncer le diagnostic à la patiente, par exemple.

Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'avez rien? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Allez-y, donnez-moi la phrase que vous allez dire. Rapidement, parce que vous êtes en train de perdre votre temps. C'est psychique.

Les autres ne vont pas comprendre. Vous n'avez rien à vous faire. Vous n'avez rien à vous faire.

Oui. Alors, les autres, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Il est le but. Pourquoi la patiente est venue vous voir? Quand vous dites l'attention, c'est comme si... c'est stigmatisant, c'est un peu stigmatisant.

Pourquoi elle vient vous voir? Non. Organique, mais psychiatrique. Elles sont fous.

Qui a de la belle indifférence? Elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Elle a besoin de quoi? De reconnaître sa souffrance.

Rassurée. Elle n'a pas besoin d'être rassurée. Inconsciemment, elle sait très bien qu'elle n'a rien.

C'est très bien que c'est un symptôme. Elle a besoin d'être... que vous reconnaissiez sa souffrance. L'empathie.

L'empathie. La définition de l'empathie, c'est la reconnaissance du symptôme. Je comprends que ce soit douloureux pour vous.

Je comprends votre douleur. Je peux imaginer à quel point c'est difficile, cette douleur. Supposons que c'est une patiente qui se plaint de douleur.

Je peux très bien comprendre combien c'est difficile de se plaindre de ce genre de douleur. Surtout quand vous vous tournez douleur. La reconnaissance.

Je reconnais la douleur. Je dis, heureusement qu'il n'y a rien de grave. Quand vous dites que c'est psychique, vous avez déjà, pour elle, pour la patiente, pour vous, vous êtes en train de la rassurer.

Mais pour elle, elle va dire, non, j'ai rien de psychique. Donc, vous l'avez déjà discriminée. La reconnaissance, quand vous dites qu'il n'y a rien de grave, c'est somatique, il n'y a rien de grave, c'est que vous avez, là encore une fois, dévalorisé, marginalisé, discriminé.

Elle a besoin d'être reconnue dans sa douleur, la douleur qu'elle présente, la douleur d'Yeltsin. Mais c'est le diagnostic d'Yeltsin. Et après, bien sûr, on peut la rassurer qu'il n'y a rien de grave.

L'examen est normal, etc. Première chose, reconnaître la réalité de la plainte, que c'est une plainte réelle. Je sais que plusieurs autres médecins avant vous, ils ont dit que tu n'as rien.

C'est juste dans ta tête, c'est psychique. Tu n'as rien d'organique. Tu n'as rien à bannir.

Parce que la patiente, elle ne vient pas mourir, elle sait qu'elle n'a rien. Elle a besoin d'une reconnaissance, donc reconnaître la réalité, rassurer sur l'absence d'affection organique. Ni rejeter, comme ce qu'on vient de voir, alors que vous avez un patient, peut-être que vous avez un patient très urgent dans le box à côté qui est un peu traumatisé.

Vous êtes en train de chercher le réanimateur ou d'appeler pour un transfert. Et là, entre

parenthèses, il vient faire quoi ? Consommer votre temps et votre énergie alors que vous pouvez traiter de réelles patients, de vrais patients. Il a reçu ce cours.

Vous savez que c'est une vraie patiente et qu'il faut reconnaître la réalité de la plainte chez la patiente. C'est vrai en termes de pronostic. Ce n'est pas aussi urgent que le patient à côté dans le box.

C'est juste une question de priorité et d'urgence. Ce n'est pas que le monsieur qui est polytraumatisé, c'est le vrai malade. Le patient qui a un appendicite, c'est le vrai malade.

Et que celle-là, la patiente hystérique, c'est une fausse patiente. Si vous comprenez que ce sont deux patients, sauf que l'urgence vitale, elle est différente. C'est tout.

Primo. Secondo. Entre parenthèses, dans le centre de santé, il y a des gens qui disent, mais pas hystérique, Il dit que le H, c'est l'hystérique.

D'ailleurs, dans certains ouvrages, on évite de dire le terme hystérique parce que certains le considèrent comme étant. Déjà, le terme hystérique, c'est stigmatisant. C'est comme si vous rejetez la patiente dès le départ.

D'accord ? Ni rejet, ni mépris parce qu'elle vient vous casser la tête. Ne pas médicaliser autrui, c'est-à-dire, je vous le dis maintenant, il n'y a pas de traitement médical à la crise d'hystérie. La crise d'hystérie est typique.

Par exemple, la perte de connaissance, il n'y a pas de traitement médical. Dans les centres de santé, qu'est-ce qu'ils font ? Sérum, injection de sérum salé. Et comme ce sont des patients suggestibles, vous leur donnez de l'eau, vous leur dites que c'est un médicament qui va vous guérir, qui va diminuer la douleur.

Elle va le boire, elle va guérir sur le champ. Parce que ce sont des patients qui sont suggestibles. D'accord ? Et les infirmiers et les médecins, ah, l'hystérique est venue, donc tu fais une injection de sérum salé parce qu'elle s'améliore à chaque fois qu'on fait ça.

Bien sûr qu'elle va s'améliorer, c'est une patiente qui est suggestible. Et là, vous donnez un placebo, elle va s'améliorer. D'accord ? Attitude neutre, bienveillante.

Le discours devrait valoriser la guérison. C'est qu'il y a des avantages à être guéri qu'à garder le même symptôme. Vous, vous allez valoriser la guérison parce que la guérison, elle va permettre, vous allez valoriser la guérison pour permettre de gérer ces problématiques autrement, différemment, pour qu'il n'y ait plus les bénéfices secondaires.

L'hospitalisation en psychiatrie, moi, je n'en ai jamais vu. On n'a jamais hospitalisé des patients pour des crises hystériques sauf les crises hystériques, théâtrales, la grande crise de Charcot où on hospitalise surtout, m'a eu à hospitaliser à l'hôpital de jour une ou deux fois dans toute ma

carrière. C'était à l'hôpital de jour, on n'a pas hospitalisé dans le service.

C'était pour une agitation, c'est tout le temps pour l'agitation psychomotrice dans la grande crise de Charcot. C'était une patiente qui avait fait une crise théâtrale, elle pouvait se blesser, donc on a dû la garder en hôpital de jour, on a donné des benzodiazépines pour la calmer. Et puis après, quand elle était plus agitée, on l'a fait sortir.

Pour séparer le patient d'un environnement conflictuel ou dramatisant, pour gérer les complications psychiatriques, notamment la dépression, bien sûr, vous allez hospitaliser quand il y a des complications dépressives graves, vous allez hospitaliser quand il y a des tentatives de suicide, etc. L'hospitalisation doit être de courte durée, parce que ça deviendra aussi un moyen pour avoir les bénéfices secondaires. Elle est hospitalisée, tout le monde va venir la voir, on va lui ramener les bonnes choses à manger, on va s'occuper de sa maison quand elle n'est pas là, donc ça va faire perdurer les symptômes.

Et contrôler les bénéfices secondaires, c'est très important. Ça, c'est en prise en charge psychothérapeutique. Traitement médical, rien.

On traite les complications. Dépression, antidépresseurs, crise avec agitation, donner un traitement pour la calmer en forme ponctuelle. Psychothérapie de soutien, ce que vous pouvez faire en tant que médecin généraliste pour ces patients qui viennent après, que vous allez convoquer après en consultation, c'est de favoriser la verbalisation de ces patients-là pour que la souffrance soit exprimée et qu'elle ne soit pas convertie en symptômes douloureux ou là sous forme de dissociation.

Donc, aider la patiente à verbaliser la douleur, à parler de ce qui lui fait mal, encourager une bonne hygiène de vie et surtout, je ne dirais pas, des pastons ou des moyens où ces patients-là peuvent s'investir au lieu d'être en souffrance psychique juste pour faciliter les choses. Oui, élément important, vous soutenez moralement votre patiente sans entrer dans ces conflits. Vous n'allez pas dire à la fameuse patiente qu'elle a des conflits avec son mari.

Oui, pas de frapper, non. On gère de façon, rappelez-vous, objective. La vie relationnelle de la patiente, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas à vous de gérer sa vie relationnelle.

Vous ne devez pas prendre partie ni partie de la patiente ni la famille de la patiente, que ce soit le mari, les parents, etc. Vous ne rentrez pas dans ces conflits pour que la relation thérapeutique soit de bonne qualité. Psychothérapie psychanalytique, gardez juste en tête que la psychanalyse, c'est le traitement de choix.

Vous allez voir dans toutes les pathologies sans le traitement de première attention. Les thérapies cognitives et comportementales sans le traitement de première attention, c'est vrai. L'hystérie, c'est la seule pathologie où la psychanalyse, c'est le traitement de choix.

C'est un traitement curatif qui doit être fait par le psychiatre. Moi, je passerai rapidement parce que c'est trop spécialisé pour vous. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez gérer une crise conversive aiguë et quand vous recevez une patiente qui a une hystérie ou qui fait des crises durables ou chroniques, vous savez comment les gérer en faisant de la psychothérapie de soutien.

C'est ça votre travail en tant que médecin généraliste. La psychanalyse, c'est pas à votre niveau. Vous pouvez adresser la patiente chez le psychiatre pour une prise en charge plus adaptée.

Gestion de la crise, bien sûr. Ce qu'on fait généralement dans les urgences, les gifles, l'incitation au mariage de la part de la famille parce que c'est vécu ou décrit par la famille comme une possession. C'est une possession diabolique.

Vous voudrez mieux la marier. C'est très fréquent. Isolement et éloignement.

S'il vous plaît, si vous êtes aux urgences, éloignez les spectateurs, hospitalisez-les ou mettez-les dans un box. Dédramatisez, rassurez la patiente. Encouragez la verbalisation.

La patiente va commencer à vous parler. Faire de l'écoute bienveillante. Écoutez avec.

Montrez à la patiente qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit par des techniques non verbales. Faire de l'écoute bienveillante.